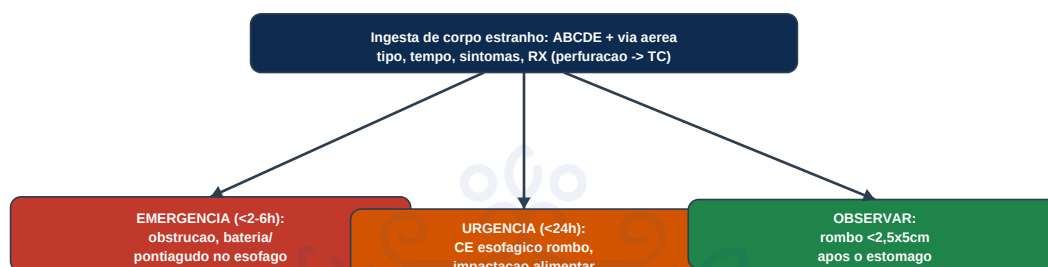


CORPO ESTRANHO DIGESTIVO — EDA x OBSERVAR

FLUXOGRAMA — TEMPO/TIPO DEFINE A URGÊNCIA

CORPO ESTRANHO — EMERGÊNCIA, URGÊNCIA OU OBSERVAR



EPIDEMIOLOGIA E PRINCÍPIOS

O QUE É

- Crianças (6 meses-6 anos), em geral acidental (moeda é o clássico); adultos por impactação alimentar (bolo de carne) — 80% têm esôfago normal, 20% têm doença esofágica
- Atenção a esofagite eosinofílica (mimetiza), psiquiátricos, presidiários (não alimentares)
- 80% se resolvem espontaneamente (eliminados); 10-20% precisam de EDA
- PRINCÍPIO: nenhum corpo estranho deve permanecer > 24h impactado no esôfago
- Sintomas: disfagia, odinofagia, sialorreia (sugere obstrução total), dor torácica; avaliar via aérea (próximo ao cricofaríngeo)

SINAIS DE ALARME

EMERGÊNCIA / PERFURAÇÃO

- BATERIA (pilha) no esôfago = SEMPRE emergência (isquemia, queimadura elétrica/química)
- Objeto PONTIAGUDO no esôfago (perfura em até 35%)
- SIALORREIA = suspeita de obstrução esofágica total
- Sintomas respiratórios (compressão da via aérea); febre/taquicardia/ENFISEMA subcutâneo -> TC (perfuração/mediastinite/abscesso/lesão vascular)
- Bateria x moeda na imagem: 'sinal do duplo halo' e 'sinal do degrau' = bateria

INDICAÇÃO DE ENDOSCOPIA POR URGÊNCIA

Categoria	Situações
Emergência (<= 2h, até 6h)	Obstrução esofágica, bateria no esôfago, objeto pontiagudo no esôfago
Urgência (< 24h)	CE esofágico não pontiagudo, impactação alimentar sem obstrução total, pontiagudo/bateria no estômago/duodeno, ímã ao alcance, objeto > 6 cm no duodeno
Não urgente / ambulatorial	Moeda no estômago assintomático (até 4 sem), bateria no estômago (observar até 48h), objeto > 2,5 cm de diâmetro
Indicação geral	Rombos > 2,5 cm, impactados no esôfago, ou que não saem do estômago após 4 semanas

MANEJO E OBSERVAÇÃO

Rx CONDUITAS

Avaliação inicial e via aérea SEMPRE (IOT se necessário); jejum; avaliar risco de aspiração
Pode-se OBSERVAR: CE não perfurocortante (exceto pilhas, baterias e ímãs), < 2 cm de diâmetro e < 5 cm de comprimento, com RX de abdome semanal por 3-4 semanas
Passagem pelo piloro (~2-2,5 cm) e ângulo duodenal (~5-6 cm): se passou o estômago, costuma eliminar em 4-6 dias
PACOTE DE DROGAS (body packer): NÃO remover por endoscopia; conservador na maioria; cirurgia se risco de overdose/obstrução
Após remoção sem complicação: alta pós-recuperação anestésica; se não removido e há risco -> internar e seriar RX; cirurgia se não resolver em ~3 dias

MODELO DE REGULAÇÃO / ENCAMINHAMENTO

RESUMO PARA ENCAMINHAMENTO

- Paciente ____ anos com ingestão de ____ (tipo: bateria/pontiagudo/rombo/alimentar) há ____; localização (RX): ____.
- Sinais de alarme: sialorreia ____, sintomas respiratórios ____, enfisema/febre ____ (perfuração?).
- Classificação: emergência (bateria/pontiagudo/obstrução no esôfago) / urgência (< 24h) / observação.
- Solicito EDA com a urgência adequada / cirurgia se perfuração; via aérea protegida no transporte.

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Criança que ingeriu uma BATERIA (pilha) impactada no esôfago. Qual a conduta?

- A) Observar por 48 horas
- B) Remoção endoscópica de EMERGÊNCIA (risco de queimadura/necrose)
- C) Alta com RX semanal
- D) Aguardar eliminação espontânea
- E) Indução de vômito

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o tempo máximo que um corpo estranho deve permanecer impactado no esôfago?

- A) 72 horas
- B) Não deve permanecer mais de 24 horas
- C) 1 semana
- D) 30 dias
- E) Indefinido se assintomático

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual corpo estranho gástrico pode ser observado com RX seriado em paciente assintomático?

- A) Objeto pontiagudo
- B) Objeto rombo < 2,5 cm de diâmetro e < 5 cm de comprimento
- C) Bateria no esôfago
- D) Ímã múltiplo
- E) Objeto > 6 cm no duodeno

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Adulto com impactação alimentar e sialorreia intensa. O que a sialorreia sugere?

- A) Boa evolução
- B) Obstrução esofágica total
- C) Doença hepática
- D) Resolução espontânea
- E) Refluxo simples

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Diante de um 'body packer' (pacote de drogas ingerido), qual a conduta?

- A) Remoção endoscópica imediata
- B) NÃO remover por endoscopia; manejo conservador na maioria, cirurgia se risco de overdose/obstrução
- C) Indução de vômito
- D) Lavagem gástrica vigorosa
- E) Alta imediata sem observação

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Bateria (pilha) no esôfago é sempre emergência endoscópica (idealmente em até 2h), pelo risco de queimadura química/elétrica e necrose/perfuração.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Nenhum corpo estranho deve permanecer impactado no esôfago por mais de 24h, pelo risco de lesão de parede, perfuração e mediastinite.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Objetos rombos < 2,5 cm de diâmetro e < 5 cm de comprimento, já no estômago e em paciente assintomático, podem ser observados com RX seriado (prazo de 3-4 semanas).

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A sialorreia (incapacidade de deglutir a própria saliva) sugere obstrução esofágica total, indicando intervenção endoscópica urgente.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

No body packer não se faz remoção endoscópica (risco de ruptura e overdose fatal); a maioria é conduzida conservadoramente, reservando-se a cirurgia para risco de overdose/obstrução.

SM24
Suporte ao Plantão Médico